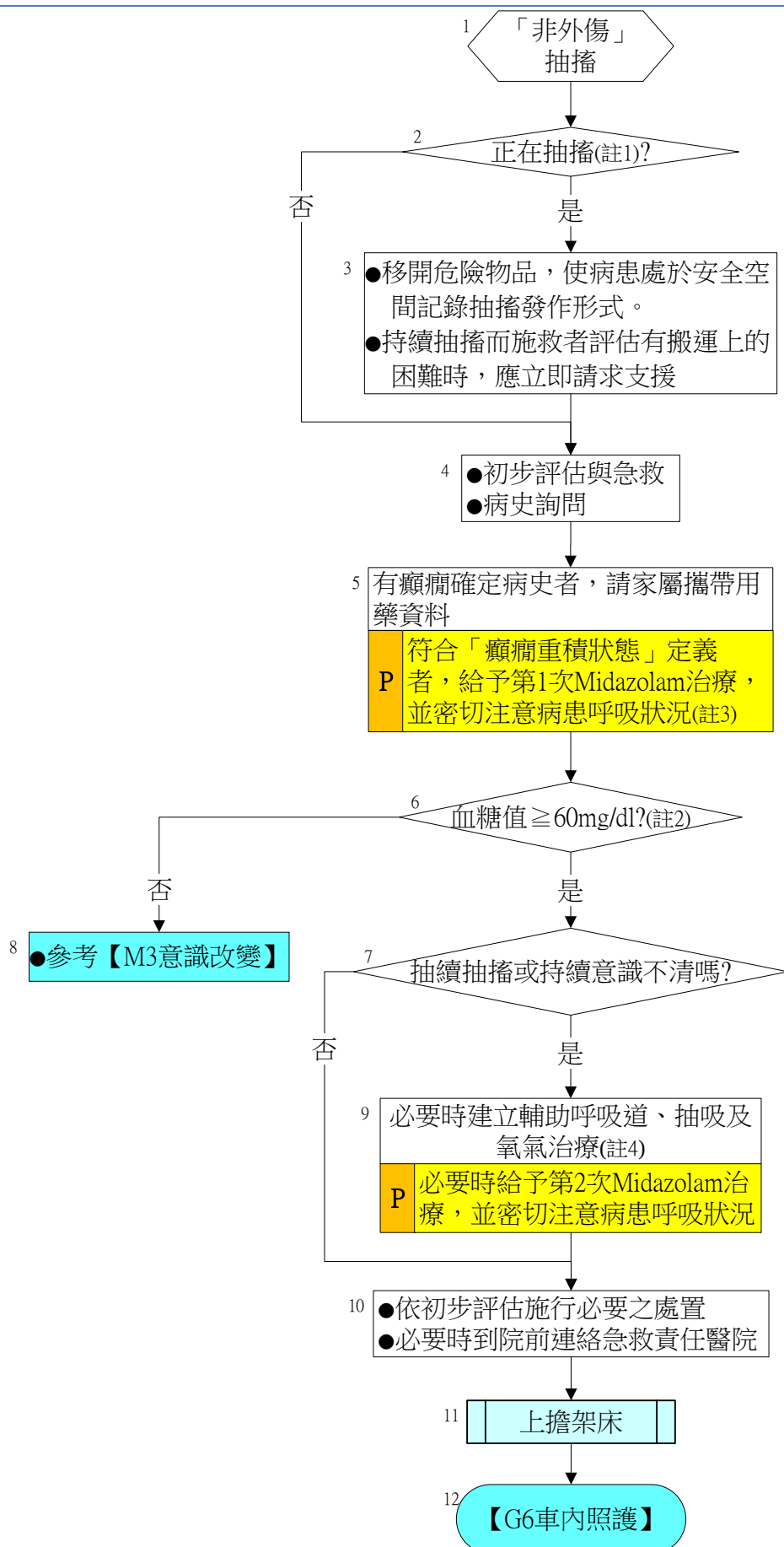


## M4 抽搐

### 程 序



## 要 旨

- 一、主訴「癲癇、抽筋、或羊癲瘋」發作的病人即建議使用本程序。
- 二、病人若發生「癲癇重積狀態」（status epilepticus）將危及生命，EMT 發現時應立刻請求支援。「癲癇重積狀態」定義為：當病人連續抽搐超過 5 分鐘，或在 5 分鐘內有2次發作且意識未能恢復。此時需緊急處置，以免產生後續嚴重之併發症，如腦部缺氧嚴重受損、橫紋肌溶解、代謝性酸中毒、肺水腫、續發性外傷等。
- 三、抽搐發作的環境若可能導致相關外傷，EMT應依外傷程序處置。

## 註 解

### 註1>

「發作」、「抽搐」、與「癲癇」之定義：

- 一、「發作」（seizure）：大腦灰質細胞突發性不正常放電所造成的臨床症狀，常有伴隨意識障礙及異常的動作。
- 二、「抽搐」（convulsion）：「發作」（seizure）時發生的全身或局部肌肉的抽動。
- 三、「癲癇」（epilepsy）：陣發性多次之「發作」（seizure）。

### 註2>

- 一、病人持續抽搐或評估有採血的困難，可不給予檢測血糖，以避免針扎的危險。
- 二、必要時建立靜脈路徑，給予葡萄糖輸液。

### 註3>

病人持續抽搐時，可不考慮輔助呼吸道，維持呼吸道即可，以避免呼吸道阻塞，若已停止抽搐時，必要時給予呼吸道處置（抽吸、口咽呼吸道、鼻咽呼吸道及SGA）及適當之氧氣治療。

### 註4>

EMTP操作項目

#### 一、給予藥物治療：

- （一）使用 Midazolam：成人與青少年 5 mg 肌肉注射或靜脈緩推 2 分鐘。
- （二）注射後約 2 分鐘後產生藥效。若 3 至 5 分鐘後仍有抽搐現象，可再重複 1 次劑量。
- （三）到院前給予總劑量，最高為 10 mg。

#### 二、考慮迅速建立靜脈路徑：考慮建立1條用生理食鹽水溶液的靜脈路徑。

三、密切監測病人的生命徵象，尤其是呼吸狀況。必要時應放置進階呼吸道。

四、孕婦癲癇發作亦適用上述處置，並請參閱【S5自然生產】及【S6產科急症】。

#### 五、藥物管理：

（一）現場使用細則：主手抽藥時，副手應複誦藥名及劑量（並檢附錄音檔備查）。

（二）每 1 位到院前使用 Midazolam 治療之病人，到院後 EMTP 應主動告知醫護人員；救護紀錄表應詳實記載，並交由醫療指導醫師核簽。

（三）Midazolam 應以單獨箱櫃上鎖保存，分隊指派專人管理（各班 1 名），每日清點、交接數量及鑰匙，並有紀錄。如遇同仁出勤抽搖案件而有注射 Midazolam，管理人應覈實領出以協助補充。

（四）救護車輛保養人每日應確實清點 Midazolam 及適當保存，並注意使用期限。

（五）專人每週協同管理人至少抽點 1 次庫存量，並有紀錄備查。